



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : حنان خميس ابراهيم عثمان

العنوان : البساتين

الحي / المدينة : البساتين

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

رقم البطاقة : 28605042100581 رقم التليفون : 01204440199

العمر (تاريخ الميلاد) : 04-05-1986 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الأورام

خطه العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للرقبة والصدر والبطن والحوض
بالصبغة [11128]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطه العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حنان خميس ابراهيم عثمان National ID: 28605042100581	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of neck, chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



طلب علاج أول مرة / متردد

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

إسم المريض ربيعاً : حنان خميس ابراهيم عثمان
المحافظة : القاهرة
الحي / المدينة : البساتين
العنوان : البساتين
رقم البطاقة : 28605042100581 رقم التليفون : 01204440199
العمر (تاريخ الميلاد) : 04-05-1986 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-06-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا أتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف أتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج : الأورام

خطة العلاج : علاج تدعيمي

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/ احمد نجيب
الاسم: د/خالد عبدالعزيز
الاسم: د/ محمد الكيلاني
الوظيفة: _____
الوظيفة: _____
الوظيفة: _____

توقيع: _____
توقيع: _____
توقيع: _____
رئيس اللجنة و مدير المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د/ _____ د/ _____ د/ _____

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : _____
خطة العلاج : _____
المستشفى : _____
جهة العلاج : _____
ملاحظات : _____
قسم : _____
نفقات : _____

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: Hanan Khamis Ibrahim
Othman
MR. : 4058

Entered by: 337 On: 2026-05-16

GUSTAVE
ROUSSY
مستشفى

تقرير طبي

المزيد

تحية طبية وبعد..

بشأن تقرير طبي
للمريض

إيماء للطلب المقدم
من

رقم طبي:

بقسم:

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالة

تاريخ وساعة : mm/dd/yyyy --:--
الخروج

تاريخ وساعة : mm/dd/yyyy --:--
الدخول

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

b.c

تدعيمي وابحث واشعة وفحوصات

تحرير في .

التاريخ : mm/dd/yyyy

وقت : --:--

الطبيب المعالج :

يعتمد .

المسيد أ.د / مدير عام المجالس الطبية

تحية طيبة وبعد
كشف حساب

علاج على نفقة الدولة

بيان بنفقات المريض / **صالح محمد إبراهيم**

عن الفترة من 2026 / 8 / 7 الى 2026 / 6 / 9

البيان	رصيد القرار	قيمة المنصرف
الرصيد	3000	
اقامة		0
كشف		0
اشراف طبي		0
اشعه (رنين - مقطعية - اخرى)		0
تحاليل طبية		0
مستلزمات		0
علاج متنوعه (بنك دم / علاج)		0
الادويه		
المتبقي	30	

المراجع



الموظف المختص



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



حضان
خميس ابراهيم عثمان
٢ من محمد فاضل - نصر الدين
بولاق الدكرور - الجيزة

١٩٨٦/٠٤/١١ ٢٨٦.٥٠.٤٢١.٠٠٥٨١

163906828

٢٠١٩/١١ ٢٨٦.٥٠.٤٢١.٠٠٥٨١

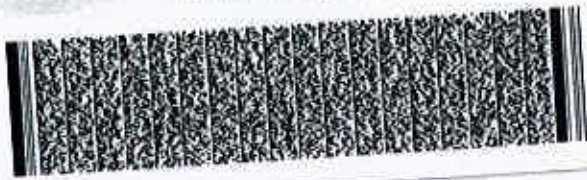
ربة منزل
أنثى

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/١١/٢٤





١



01/21/2026

MDT FORM

Name:	Hanan Khamis Ibrahim Othman	MRN:	4958
Age:	40 Y	ID:	
Menopausal Sta	pre	Phone:	01017020014
NRS SCORE:		Marital Status:	divorced
BNI:		Family History:	
CO Morbidity:	m. free	Reason Of MDT:	REMDT

Clinical Data:

BX: IDC 2
ER: 7/8 PR: 8/8 HER2: 0 KI67: 40%

R

L

Sonomammography:

RT LOQ MASS + indeterminate axillary LNs

Mets Workup:

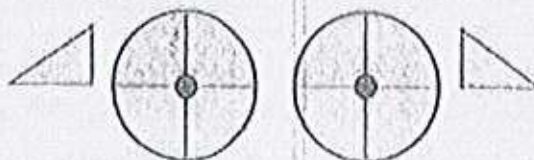
ct bil hilar and mediastinal lymphadenopathy + pulmonary nodule + splenic focal lesion

PET CT active supra and infradiaphragmatic LNs suggestive sarcoïdosis non active pulmonary nodules

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

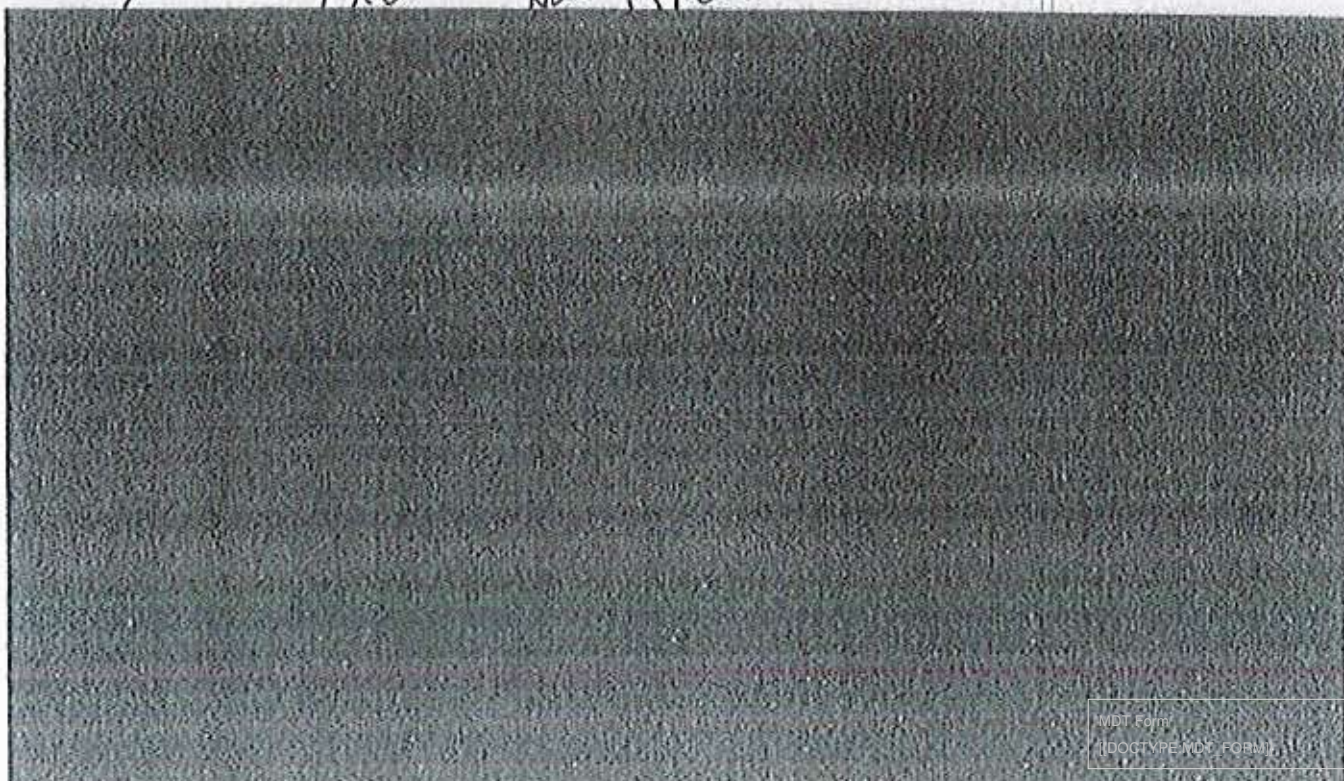
FOR TARGET AXILLARY US, CT guided biopsy from mediastinum, clip o f breast lesion. start NACHT, then re MDT after 3 cycles



T N M

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. يوسف روبعي	د. أحمد محمد	د. أحمد محمد	د. أحمد محمد		



Patient Name: Hanan Khamis Ibrahim Othman	Date : 10/11/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 39 Year(s)
Medical ID: 3098/2025	Pat. ID: 132845

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:

- Right pulmonary upper lobe nodule measures about 1.7 mm is seen.
- Multiple enlarged bilateral hilar and mediastinal (prevascular, anterior mediastinal, retrocaval, carinal, subcarinal, pre and paratracheal) discrete and amalgamated lymph nodes forming soft tissue masses at their anatomical sites, largest measuring about 5.2 x 2.5 cm in axial dimensions at subcarinal region.
- Bilateral axillary lymph nodes are seen.
- No masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- Enlarged spleen showing few hypodense focal lesions, largest measuring about 1 cm in diameter.
- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- An IUCD is seen.

*Scanned skeleton: no definite worrisome lytic or sclerotic focal lesions.

Opinion:

- Right pulmonary nodule.
- Bilateral hilar and mediastinal lymphadenopathy, suggestive of neoplastic process/ Lymphoma, for histopathology.
- Right pulmonary nodule.
- Few splenic focal lesions? Lymphomatous deposits, for follow up.



AL SHROOUK SCAN

الشروق للأشعة

15184

o **Musculoskeletal system:**

- o Diffuse patchy increased FDG uptake within axial skeleton with focal areas of increased activity seen along the pelvic bones and medial end of the right clavicle yet no definite lytic or sclerotic osseous lesions.
- o Left iliac bone sclerotic focus, *bone Island*.

OPINION:

- o Metabolically active right breast neoplasm associated with small ipsilateral low grade metabolically active lymph nodes.
- o Metabolically active supra and infradiaphragmatic lymph nodes suggestive of sarcoidosis rather than lymphoma or metastatic disease, for clinical correlation and if needed histopathology.
- o Non-metabolically active few small bilateral pulmonary nodules with hypermetabolic spleen and bone marrow, for clinicolaboratory correlation and follow-up.

Radiologist

Dr. Mohamed Gamal, MD

Nuclear Medicine physician

Dr. Nafisa Dessouki, MD



AL SHROOK SCAN

الشروق للاشعة

15184

○ Lungs:



- Few small bilateral pulmonary nodules with no significant FDG uptake, the largest measures 0.7cm over right upper lobe nodule.

○ Spleen

- Bulky spleen with diffuse increased FDG uptake and no FDG avid focal lesions, SUVmax 6.1.
- Few hypodense focal lesions with no significant FDG uptake, the largest measures 1x0.7cm, possibly cysts.

Rest of the body:

○ Head and Neck region:

- Homogenous texture of thyroid gland with no abnormal FDG uptake.
- Normal FDG uptake within the salivary glands. Normal physiological uptake within the brain with no focal lesion.
- Increased nasopharyngeal activity, likely inflammatory.

○ Mediastinum and chest wall:

- Average size heart with normal myocardial increased FDG activity.
- Normal appearance of trachea-bronchial tree as well as the esophagus.

○ Abdomen and pelvis:

- Average sized liver with no FDG avid focal lesions.
- Normal adrenals, pancreas and kidneys.
- No FDG avid masses within the bowel.
- IUCD in place.
- Small non FDG-avid left adnexal cyst, likely physiologic.





AL SHROOK SCAN

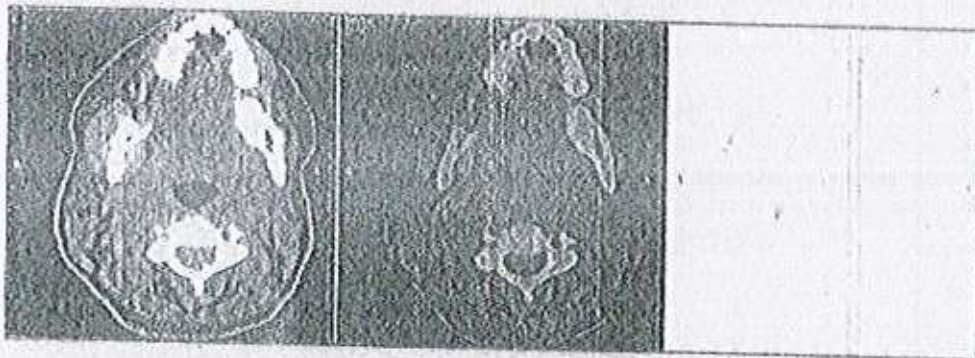
الشروق للامعة

15184

◦ Left breast and axilla:

- Low grade FDG activity by mild nodular parenchyma. No FDG avid breast lesions.
- No significant FDG uptake by axillary LNs, with preserved hila, likely inflammatory.

◦ Lymph nodes:

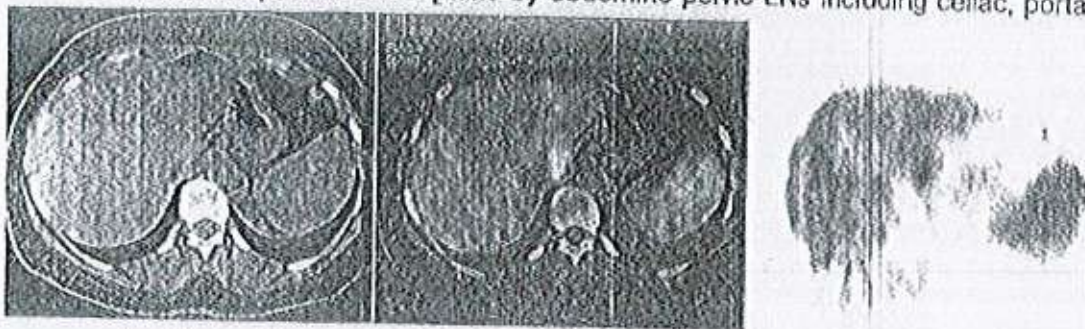


- Cervical: FDG uptake by bilateral cervical level Ib, II, III and IV LNs. SUVmax 5.2 as measured over 1.4x1.2cm right level II LN.



- Mediastinal: Increased FDG uptake by mediastinal LNs including superior mediastinum, anterior mediastinum, paratracheal, tracheobronchial, prevascular, subcarinal and bilateral hilar. SUVmax 9.7 as measured over 1.6x1.2cm right hilar LN.

- Abdomino-pelvic: FDG uptake by abdomino-pelvic LNs including celiac, porta-



hepatis ,porto-caval, aorto-caval, left para-aortic, SUVmax 5.1 as measured over portaheptis node rather than caudate lobe focal lesion.

Pat Name: Hanan Khamis Ibrahim Othman

Pat ID: 10173075

Date: 01/01/2026

Pat. Age 39 Year(s)

Ref.Prof.Doc: Gistave Rosy

¹⁸F-FDG PET/CT examination

CLINICAL: A patient presented with pathologically proven right breast IDC grade II, for assessment.

EXAM: Prepared according to body weight.

RESULTS:

Prior to administration of the radiotracer, blood glucose level was 136 mg/dl.

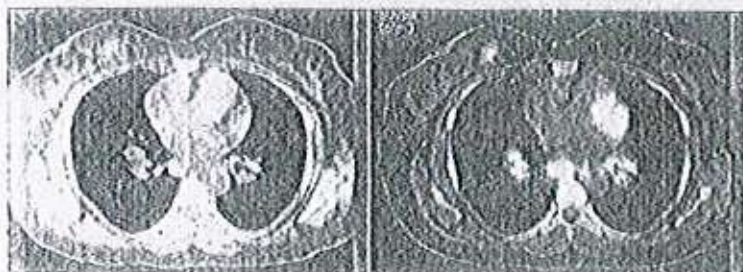
CT images without contrast for attenuation and localization followed by PET images from the skull vertex to mid thighs were obtained.

Initial PET/CT study.

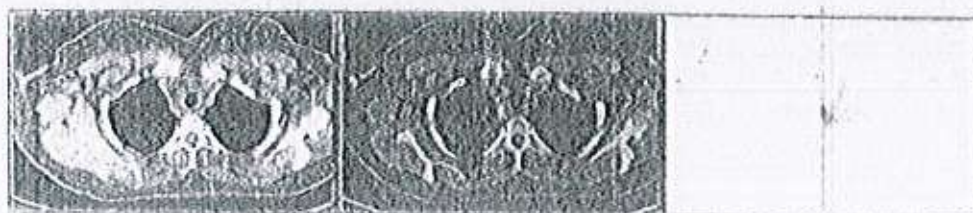
Scanned Stimmax reference ~ 4.7

Findings:

Right breast and axilla:



- o Increased FDG uptake by irregular right breast IQ nodular lesion within breast parenchyma at 3 o'clock position, SUVmax 5.2 and measures about 2.4x1.5cm.
- o No skin or chest wall invasion.
- o Low grade FDG uptake by axillary level I LNs, SUVmax 1.4 as measured over 1.3x0.9cm LN.



Patient ID: 89194

Age: 35 Yr

Patient Name English: Hanan Kharrat

Report Date: 2025/10/14 12:15:14 P

Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: 39y/o complaining of palpable right breast lump, no family history.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Fairly dense breast parenchyma (ACR density b).
- The right breast shows a lower inner quadrant dense spiculated lesion with microcalcifications seen within and beyond the lesion of microcalcification including the lesion measures 61x30 dimensions 5.7cm from the nipple.

Ultrasound Right breast:

- Preserved fibro glandular parenchyma.
- No cystic lesions.
- The right LIQ shows a hypoechoic spiculated lesion seen; b measures 27x15mm in dimensions with central vascular by color Doppler.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Right axillary level I indeterminate axillary LN measures 1 longitudinal axis with diffuse cortical thickening 3mm.

Left breast

- Fairly dense breast parenchyma (ACR density b).
- No asymmetry, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.

Ultrasound left breast:

- Preserved fibro glandular parenchyma.
- A cluster of micro cysts is seen at 3-4 o'clock zone n 12.5 dimensions and at 12 o'clock zone b measures 9.3x4.4mm. An oval hypoechoic probably benign lesion seen at 9 o'clock zone c measures 9.5x5.5mm in dimensions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 5): LOQ neoplastic lesion as described BIRADS 5.